

37. 実践的な脳

所要時間 : 13:08

学習シート

コース概要

このビデオ「実践的脳」は、脳とその拡張に焦点を当てた詳細な生体力学的アプローチを紹介しています。インストラクターは、心臓や消化管の軸への働きかけなど、効果的な再活性化戦略を探求しながら、患者の拡張レベルを特定する方法を教えています。続いて、頭蓋と橋の屈曲運動の探求があり、触診の際に講じるべき特定の注意点も説明されています。拡張の感覚に焦点を当てることで、施術者は生体力学的発生学に関連するリズムと同期性を理解し、脳化の動きをサポートする方法を学びます。このセッションは理論的かつ実践的であり、学生は理解を深め、実践を向上させるためのスキルを習得できることを約束します。

37. 実践的脳：生体力学的アプローチ

I. 初期ポジショニングと拡張の探索

患者の上、特に島のレベルに位置します。ここに手を置き、親指をわずかに交差させ、肘と手首がテーブルにしっかりと支えられていることを確認します。

触診は非常に優しく行います。フィールドの**拡張**を感じ取ろうとします。

A. 拡張の欠如の特定

評価すべき最初のことは、**拡張**のレベルです。拡張が不十分で、十分に「押し返されない」場合、何かがうまくいっていない兆候です。

多くの場合、即座に強い拡張が期待されますが、常にそうとは限りません。

B. 拡張不足の場合の再活性化戦略

拡張が不十分な場合、システムを**再活性化**するためにいくつかの道筋を探る必要があります。

- **心臓**：心臓を軽くすることは、しばしば非常に効果的なアプローチです。
- **消化軸**：消化軸（腸間膜、腸間膜動脈）または腹腔軸に働きかけることで、必要な拡張が得られることがあります。
- **仙骨と椎弓根**：仙骨と椎弓根のレベルまで遡ることも役立ちます。

一般的に、心臓または消化軸に働きかけることで、より迅速かつ効果的な結果が得られます。

II. 屈曲運動と脳化

拡張が現れると、拡張に続いて前方への**屈曲**運動を感じます。これは頭部屈曲であり、脳を心臓へと導きます。

その背後で、**頸部屈曲**の動きを知覚する必要があります。このレベルでわずかな欠損を感じる場合、それは頸部または構造的な矯正の必要性を示しています。

A. 橋の屈曲と終脳化

次に、小指に集中し、**橋の屈曲**を探します。動きは下降します。

そして、新たな拡張が現れます。この段階で、手を開くことができます。これは**終脳化**プロセスの始まりであり、後頭部から側頭部へと回復されます。

B. よくある間違いと注意点

ほとんどの間違いは、脳に直接触れるときに発生します。「その周波数」にない場合、脳に触れてはなりません。

- 私は上方に位置し、親指で触れず、適切な距離を保ちます。
- 親指で非常に優しい**支点**を作り、重要な支点とします。

C. 拡張の感覚

良い拡張は、熱の平面と優しい押し出しの感覚として感じられます。

III. 連続的な動きと伴走

非常に優しい動きを行います。これはまだ私の「H-橋島」ではありません。前方への屈曲運動を行います。動きはうまく下降しますが、わずかにねじれ（例えば左へ）が生じることがあります。このねじれに非常に軽く伴走します。

この段階で、小さな修正が必要になることがあり、おそらく心臓のレベルです。動きが完璧ではない瞬間があるかもしれませんが、それは問題ありません。

A. 屈曲の下降と橋の平面

次に、患者がはっきりと感じるはずの屈曲の下降へと向かいます。これは問題なく下降します。

これが確立されたら、**橋の平面**へと進みます。ここでも、小さな介入が必要になることがあります。

B. 終脳の平面と上昇する拡張

橋の平面の後、**終脳の平面**、終脳の原基に注意を戻します。動きは私の方へ来るはずで、拡張を観察します。

「**ヒッチマン**」に位置します。動きは私の方へ回転し、拡張し、上昇します。

C. 脳化の大きな動き

動きは再び始まり、下降し、表現されます。私はゆっくりと大きな屈曲、**脳化**の大きな動きへと下降します。この動きを後頭部のレベルで回復します。

この動きに伴走することが重要であり、強制してはなりません。それが現れるのを待ち、それからそれに従います。動きはすでに存在しており、「描かれたレール」のように、特定のリズムを持っています。私たちは既存の**パターン**を再現するだけです。

IV. リズムの理解と同期性

このパターンは、周期的に繰り返されるサイクルという意味で再現可能ではありません。それは常にそこにあるシステムであり、**体内の記述**です。これこそが**生体力学的胚発生学**の本質です。構造（耳、眼系、視覚ブラコードなど）の原基は、このパターンに従って形成されます。

このガイドラインを理解した後、この理解に要素を追加していきます。

A. 出現する構造と動きを結びつける

この動きを理解することで、**脳室**がどのように形成されるか、**硬膜**がどのように追従するか、**頭蓋骨**がどのように形成されるかがわかります。何かがブロックされている場合（まだ知らないレベル）、タイミングと同期現象の知識に頼ることができます。

例えば、**動脈**や特定の電気レベルを探することができます。患者は起こっていることを感じるすることができます。

B. 心臓のダイナミクスの重要性

心臓の**ダイナミクス**をよく知ることが不可欠です。時には、拡張が片側（例えば左側）でより大きいことがあります。

C. 過度な知性化の回避

感じたことを過度に知性化しないことが重要です。過度な精神活動は「辺縁系に過剰な電気を送り込み」、微妙な知覚を妨げる可能性があります。

V. 実践例：感覚の分析

評価時：

- 拡張は穏やかで、完全ではありません。屈曲は良好ですが、活性化が不足しています。
- リズムは変動します。動きは左側のレールに大きく傾き、減速します。
- **前頭葉**の深部に到達するのが難しい場合があります。

A. 動きの進行

次に、橋のシステムへと進み、患者のチューブが上昇します。私は支点となり、それが押されます。特に右側の側方排出がより強く始まります。

患者は「下で荷物を受け取ります」。最初の開始が少し遅かった後、動きはうまく回復します。

B. 患者の証言

患者は、拡張を妨げていた左側の固定を「始動」させ、手放す必要があったかのように、困難な始まりを説明しました。最初の屈曲は困難でした。

接続が確立されると、システムは「ブロックが解除されました」。これは**フォーミュラ1**の運転を学ぶことに似ています。最初は不器用ですが、学習するにつれてうまくいくようになります。

C. 伴走の鍵

- **環境と空間**：呼吸させ、動きを傾ける。
- **漸進性**：徐々に入り込み、体の「記述」に接続する。
- **聴覚の集中**：脳のレベルで聴覚を集中させ、もし「うまくいかない」場合は、他の場所を観察する。

これは**同期性**の問題です。適切な言葉を見つけ、この同期性で作業するために「同期性を作り出す」必要があります。